

정상 흉부 영상의학 소견 및 검사법

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016년 | 총 15문제

2025년 Q22 [홍정희] 정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법

Q22. 22. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- 1) X선의 방향이 환자 몸의 앞에서 뒤쪽으로 지나가는 검사이다.
 - 2) 정상 Chest PA (후전위) 에서는 심장이 정상크기로 관찰되는 것이 특징이며 scapula가 양측 폐야를 가리지 않아야 하며, clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.
 - 3) 정상적으로 우측 횡격막이 7th 갈비사이공간 (intercostal space)에 위치하면 흡입 정도가 적당하다.
 - 4) 노출 정도는 intervertebral disc는 보이거나, retrocardiac vascular marking이 보이지 않는 것이 적당하다.
 - 5) 정상적으로 우측 횡격막이 좌측보다 약간 낮다.
- 1) chest PA(후전위)는 X선이 환자 몸의 뒤쪽에서 앞쪽으로 지나가는 검사입니다.
 - 2) 정답 선지
 - 3) 우측 횡격막이 10th 갈비사이공간(intercostal space)에 위치해야 합니다.
 - 4) 노출 정도는 intervertebral disc space가 겨우 보이고, retrocardiac space의 lung marking이 보일 정도가 적당합니다.
 - 5) 간이 우측에 있기 때문에, 우측 횡격막은 좌측보다 1/2늑간정도 높습니다.
- ** 강의록 참고

정답: 2)

해설

¥22년도 27번

- 1) chest PA(후전위)는 X선이 환자 몸의 뒤쪽에서 앞쪽으로 지나가는 검사입니다.
 - 2) 정답 선지
 - 3) 우측 횡격막이 10th 갈비사이공간(intercostal space)에 위치해야 합니다.
 - 4) 노출 정도는 intervertebral disc space가 겨우 보이고, retrocardiac space의 lung marking이 보일 정도가 적당합니다.
 - 5) 간이 우측에 있기 때문에, 우측 횡격막은 좌측보다 1/2늑간정도 높습니다.
- ** 강의록 참고

2025년 Q23 [홍정희] 정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법

Q23. 23. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?

- 1) Acinus 폐세엽으로 영상검사로 관찰할 수 있는 가장 작은 해부학적 구조 단위이다.
- 2) 소엽중심구조물 (Central core structure)는 폐동맥과 이와 같이 주행하는 세기관지 (lobular bronchiole)가 있다.
- 3) Respiratory bronchiole 분지 이후의 구조물이다.
- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, perilymphatic distribution이라고 한다.
- 5) 결절의 위치가 소엽간중격(interlobular septum)에 위치할 경우 centrilobular distribution이라고 한다.
- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, centrilobular distribution이라고 합니다.
- 5) 결절이 소엽간중격에 위치하는 경우 perilymphatic distribution이라고 합니다.

정답: 2)

해설

¥22년 28번

그림에서 화살표로 표시된 구조물은 secondary pulmonary lobule입니다.

영상검사로 관찰할 수 있는 가장 작은 해부학적 구조물로, 3~5개의 acinus로 구성됩니다. Lobular bronchiole 분지 이후의 구조물이며, 중심부에는 terminal bronchiole과 폐동맥, 가장자리에는 폐정맥과 림프관이 위치합니다.

- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, centrilobular distribution이라고 합니다.
- 5) 결절이 소엽간중격에 위치하는 경우 perilymphatic distribution이라고 합니다.

2023년 Q19 [김진영] 정상 영상의학 소견 및 검사법

Q19. 19. Chest X-ray PA (posteroanterior) 사진과 AP (anteroposterior)의 차이에 대한 설명으로

맞는 것은?

- 1) Chest PA는 주로 누운 자세에서 촬영되며 chest AP는 선 자세에서 촬영된다.
- 2) Chest PA사진은 clavicle이 폐첨부와 중첩되며, chest AP사진은 clavicle이 폐첨부와 분리된다.
- 3) Chest PA사진에서 heart는 정상보다 커져 보이나, chest AP사진은 heart가 정상 크기로 보인다.
- 4) Chest PA사진에서는 우측 횡경막이 좌측보다 2cm정도 낮은 것이 정상이다.
- 5) Chest AP사진에서는 scapula가 폐야와 중첩되지만, Chest PA사진에서는 폐야와 분리된다.
- 2) PA는 폐첨부와 분리, AP가 폐첨부와 중첩됩니다.
- 3) PA사진에선 심장이 정상 크기로 나타나지만 AP사진에선 심장이 정상보다 크게 나타납니다.
- 4) PA에선 우측 횡경막이 좌측보다 2cm 정도 높은 것이 정상입니다.
- 5) 옳은 선지입니다.

정답: 5

해설

- 1) PA는 선 자세에서 촬영하고 AP는 일어서기 힘든 환자의 경우 누워서 촬영하는 기법입니다.
- 2) PA는 폐첨부와 분리, AP가 폐첨부와 중첩됩니다.
- 3) PA사진에선 심장이 정상 크기로 나타나지만 AP사진에선 심장이 정상보다 크게 나타납니다.
- 4) PA에선 우측 횡경막이 좌측보다 2cm 정도 높은 것이 정상입니다.
- 5) 옳은 선지입니다.

2023년 Q20 [김진영] 정상 영상의학 소견 및 검사법

Q20. 20. 다음 Chest radiograph에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) Chest Apicography (폐첨촬영)사진이며, 폐첨부를 보기위해 촬영한다.
 - 2) Chest Lateral decubitus view로 촬영된 사진이며, 소량의 흉수도 잘 관찰된다
 - 3) Chest AP 사진이며, 왼쪽 흉수가 관찰된다.
 - 4) 선 자세에서 촬영하며, Chest PA사진이다.
 - 5) 옆으로 누워서 촬영하며, chest AP사진이다.
- 1) 틀린 선지입니다.
 - 2) 옳은 선지입니다.
 - 3) 틀린 선지입니다.
 - 4) 틀린 선지입니다.
 - 5) 틀린 선지입니다.

정답: 2

해설

강의록에 있는 사진으로 Lateral decubitus view 사진이며 흉수와 흉막삼출 확인을 위해 시행합니다.

- 1) 틀린 선지입니다.
- 2) 옳은 선지입니다.
- 3) 틀린 선지입니다.
- 4) 틀린 선지입니다.
- 5) 틀린 선지입니다.

2022년 Q27 [김진영] 정상 영상의학소견 및 검사법

Q27. 27. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- 1) X선의 방향이 환자 몸의 앞에서 뒤쪽으로 지나가는 검사이다.
 - 2) 정상 Chest PA (후전위)에서는 심장이 정상크기로 관찰되는 것이 특징이며 scapula가 양측 폐야를 가리지 않아야 하며, clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.
 - 3) 정상적으로 우측 횡격막이 7th 갈비사이공간 (intercostal space)에 위치하면 흡입 정도가 적당하다.
 - 4) 노출 정도는 intervertebral disc는 보이거나, retrocardiac vascular marking이 보이지 않는 것이 적당하다.
 - 5) 정상적으로 우측 횡격막이 좌측보다 약간 낮다.
- 2) 맞는 선지입니다.
 - 3) 우측 횡격막이 10th posterior intercostal space에 위치해야 합니다.
 - 4) 노출 정도는 disc space가 겨우 보이고 retrocardiac space의 lung marking이 보일 정도가 적당합니다.
 - 5) 우측 횡격막은 간 때문에 좌측보다 1/2늑간 정도 높습니다.

정답: 2

해설

- 1) chest PA는 X선이 환자 몸의 뒤쪽에서 앞쪽으로 지나가는 검사입니다.
- 2) 맞는 선지입니다.
- 3) 우측 횡격막이 10th posterior intercostal space에 위치해야 합니다.
- 4) 노출 정도는 disc space가 겨우 보이고 retrocardiac space의 lung marking이 보일 정도가 적당합니다.
- 5) 우측 횡격막은 간 때문에 좌측보다 1/2늑간 정도 높습니다.

2022년 Q28 [김진영] 정상 영상의학소견 및 검사법

Q28. 28. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?

- 1) Acinus 폐세엽으로 영상검사로 관찰 할 수 있는 가장 작은 해부학적 구조 단위이다.
 - 2) 소엽중심구조물에 (Central core structure)는 폐동맥과 이와 같이 주행하는 세기관지 (lobular bronchiole)가 있다.
 - 3) Respiratory bronchiole분지 이후의 구조물이다.
 - 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, perilymphatic distribution이라고 한다.
 - 5) 결절의 위치가 소엽간중격 (interlobular septum)에 위치할 경우 centrilobular distribution이라고 한다.
- 1) secondary pulmonary lobule은 3-5개의 acinus로 구성되며 직경이 1-2.5cm정도이며 septum이 두꺼워서 CT에서 관찰가능합니다.
- 2) 맞는 선지입니다.
- 3) respiratory bronchiole 분지 이후의 구조물은 primary pulmonary lobule이며, secondary pulmonary lobule은 lobular bronchiole 분지 이후의 구조물입니다.
- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우 centrilobular distribution이라고 합니다.
- 5) 결절의 위치가 소엽간중격에 위치할 경우 perilymphatic distribution이라고 합니다.

정답: 2

해설

그림은 secondary pulmonary lobule입니다. 강의록에 비슷한 사진이 있으니 참고하시면 될 것 같습니다.

- 1) secondary pulmonary lobule은 3-5개의 acinus로 구성되며 직경이 1-2.5cm정도이며 septum이 두꺼워서 CT에서 관찰가능합니다.
- 2) 맞는 선지입니다.
- 3) respiratory bronchiole 분지 이후의 구조물은 primary pulmonary lobule이며, secondary pulmonary lobule은 lobular bronchiole 분지 이후의 구조물입니다.
- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우 centrilobular distribution이라고 합니다.
- 5) 결절의 위치가 소엽간중격에 위치할 경우 perilymphatic distribution이라고 합니다.

2021년 Q23 [김진영] 정상 흉부의 영상의학 소견 및 검사법

Q23. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

1) X선의 방향이 환자 몸의 앞에서 뒤쪽으로 지나가는 검사이다.

정상 Chest PA (후전위)에서는 심장이 정상크기로 관찰되는 것이 특징이며

2) scapula가 양측 폐야를 가리지 않아야 하며, clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.

정상적으로 좌측 폐문(left hilum)이 우측 폐문 (right hilum) 보다 1-2cm 정도 아래에 위치

3) 한다.

노출 정도는 intervertebral disc는 보이거나, retrocardiac vascular marking이 보이지 않는

4) 것이 적당하다.

5) 정상적으로 우측 횡격막이 좌측보다 약간 낮다.

정답: 2

해설

야마입니다.

1. X선의 방향이 환자 몸의 뒤에서 앞쪽으로 지나가는 검사입니다.

2. 맞는 선지

3. 좌측 폐문이 우측 폐문보다 위에 위치합니다.

4. 노출 정도는 retrocardiac vascular marking이 보일 정도로 합니다.

5. 우측 횡격막이 간 때문에 왼쪽보다 약간 높ی 있습니다.

2021년 Q24 [김진영] 정상 흉부의 영상의학 소견 및 검사법

Q24. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?

1) Primary pulmonary lobule (일차 폐소엽) 이다.

소엽중심구조물에 (Central core structure)는 폐동맥과 이와 같이 주행하는

2) 세기관지 (lobular bronchiole)가 있다.

3) Respiratory bronchiole 분지 이후의 구조물이다.

4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, perilymphatic distribution이라고 한다.

결절의 위치가 소엽간중격 (interlobular septum)에 위치할 경우 centrilobular

5) distribution이라고 한다.

정답: 2

해설

야마입니다.

1. 이차 폐소엽입니다.

2. 맞는 선지

3. 이차 폐소엽은 lobular bronchiole 분지 이후의 구조물입니다. 참고로 acinus
는 terminal bronchiole 분지 이후, 일차 폐소엽은 respiratory bronchiole 분지
이후의 구조물입니다.

4. 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, centrilobular distribution입니다.

5. 결절의 위치가 소엽간중격에 있을 경우, perilymphatic distribution입니다.

2020년 Q1 □ 흉부 X선 (Chest PA) 촬영 기법 및 판독

Q1. 다음 중 흉부 후전위 단순 촬영(Chest PA, posteroanterior view)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 감마선(gamma ray)을 이용한 영상 검사이다.
- 2) 정상 Chest PA에서는 심장이 크게 관찰되는 것이 특징이며, scapula가 양측 폐야를 가리지 않고, clavicle이 사선으로 위치하여 폐 첨부(lung apex)를 가리지 않아야 한다.
- 3) 흡기(inspiration) 시 촬영하여야 하며, 횡격막(diaphragm)이 제9~10 늑간(intercostal space) 수준에 위치하는 것이 적절하다.
- 4) 정상적으로 좌측 폐문(left hilum)이 우측 폐문(right hilum)보다 1~2 cm 정도 아래에 위치한다.
- 5) 노출 정도는 심장 후방 혈관 음영(retrocardiac vascular marking)이 보이지 않는 정도가 적절하다.

정답: 3

해설

정상 Chest PA는 흡기 시 촬영하며, 이때 횡격막은 제9~10 전방 늑간(또는 제9~10 후방 늑간) 수준에 위치하는 것이 적절한 흡기 상태로 간주된다. ① X선(X-ray)을 이용한 검사이며 감마선은 핵의학 검사에서 사용된다. ② 정상 Chest PA에서 심장은 흉곽 폭의 50% 미만으로 작게 보여야 하며(PA에서 심장이 작게 보이는 것이 특징), scapula는 양측 폐야 밖으로 회전시켜 가리지 않도록 해야 한다. ④ 정상적으로 좌측 폐문이 우측 폐문보다 1~2 cm 위(상방)에 위치한다. ⑤ 적절한 노출에서는 retrocardiac vascular marking이 보여야 한다(보이지 않으면 과노출).

2020년 Q3 [이진희] 흉부 X선 판독 - 폐 결절(Pulmonary nodule) vs Mass

Q3. 다음 흉부 단순 촬영(CXR) 소견에 대한 설명으로 옳은 것은? (영상: 우측 하부에 경계가 비교적 명확한 등근 고밀도 병변이 관찰됨)

- 1) 3 cm보다 큰 것을 nodule, 3 cm보다 작은 것을 mass라고 한다.
- 2) 우하엽(right lower lobe)에 간유리 음영(ground-glass opacity)이 보인다.
- 3) 우하엽(right lower lobe)에 mass가 관찰된다.
- 4) 우하엽(right lower lobe)에 무기폐(atelectasis) 소견이 보인다.
- 5) 우하엽(right lower lobe)에 경화(consolidation)가 보인다.

정답: 3

해설

영상에서 우측 하부에 경계가 명확한 등근 고밀도 병변이 관찰되며, 크기가 3 cm 이상인 경우 mass로 정의한다. ① 정의가 반대로 기술되어 있다. 3 cm보다 작은 것을 nodule, 3 cm보다 큰 것을 mass라고 한다. ② 간유리 음영은 폐 실질의 음영 증가가 있으나 혈관 음영이 보존되는 소견으로, 이 영상의 소견과 다르다. ④ 무기폐는 엽 또는 분절 단위의 허탈로 나타나며, 국소 등근 병변과 다르다. ⑤ Consolidation은 폐포강 내 삼출물로 인한 음영 증가이며, 경계가 불명확한 경우가 많다.

2019년 Q13 [김진영 교수님] 정상 흉부 영상의학

Q13. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

1) 감마선을 이용한 검사이다.

정상 Chest PA (후전위)에서는 scapula가 양측 폐야를 가리지 않으며

2) clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.

3) 노출정도는 폐문이 보이는지를 따지며 intervertebral disc space가 보이지 않아야 한다.

4) 폐혈관 음영 (pulmonary vascularity) 정상적으로 upper, lower 모두 균등하게 분포해야 한다.

5) 정상적으로 우측 폐문(left hilum)이 좌측 폐문 (right hilum) 보다 1-2cm 정도 위에 위치한다.

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 2

해설

1) 감마선 -> X선

2) 맞음

3) intervertebral space는 잘 보여야한다.

4) 폐혈관 음영은 균등하게 분포하지 않습니다.

5) 좌측 폐문이 우측 폐문보다 1-2cm 위에 존재하죠?

김진영 교수님은 수업 시간에 했던 말씀에서 시험 문제를 잘 내십니다! 어렵지 않게 내시니,

커피 한 잔 마시고 수업 듣는 게 이득!

2019년 Q14 [교수님] 정상 흉부 영상의학

Q14. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?

1) Primary pulmonary lobule (일차 폐소엽) 이다.

소엽은 소엽간중격 (interlobular septum), 소엽중심구조물 (central core) 그리고 흉막 (pleura)

2) 로 구성된다.

3) 소엽중심구조물에 (Central core structure)는 폐정맥과 이와 같이 주행하는 세기관지가 있다.

4) Respiratory bronchiole 분지 이후의 구조물이다.

결절들이 보일 때 centrilobular nodule, peri-lymphatic nodule,

5) randomly distributed nodule로 분류하는 기준은 소엽과 연관된 분포로 판단한다.

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

위의 문제는 일차 폐소엽에 관한 문제이다

1) CT에서 볼 수 있는 가장 작은 단위는 Secondary pulmonary lobule. 일차 폐소엽은 너무 작아서 안보인다.(수업시간에 하신 설명)

2) 소엽의 구성은 interlobular septum, central core structure, parenchyme(acinus)로 구성된다.

3) 소엽중심구조물에는 pulmonary arteriole, bronchiole이 해당된다.

4) Primary pulmonary lobule에 관한 설명이다.

5) 맞는 설명

마찬가지로 강의록 내용과 교수님께서 하신 수업시간 설명까지 알아야 합니다!

2019년 Q16 [김진영 교수님] 흉부질환의 영상의학 소견

Q16. 다음 다른 두 명 환자의 chest PA이다. 각각 음영증가성 병변의 실루엣징후의 유무와 병변의 위치를 맞게 기술한 것은?

약자: LUL: left upper lobe, 좌하엽: left lower lobe

A) 실루엣 징후 양성, 좌상엽 설분절

1) B) 실루엣 징후 음성, 좌하엽

A) 실루엣 징후 음성, 좌상엽 설분절

2) B) 실루엣 징후 양성, 좌하엽

A) 실루엣 징후 양성, 좌하엽

3) B) 실루엣 징후 양성, 좌상엽 설분절

A) 실루엣 징후 음성, 좌하엽

4) B) 실루엣 징후 양성, 좌하엽

A) 실루엣 징후 음성, 좌하엽

5) B) 실루엣 징후 양성, 좌상엽 설분절

20190617 의학과2 호흡기학

정답:

해설

실루엣 징후 양성 음성을 판별하는 문제입니다. 심장이랑 경계가 지어지는지 확인하면 되겠죠?

A는 심장이랑 경계가 명확하게 지어지는 걸 봐서 좌하엽이고,

lar gu B는(lin 심장이랑 병변의 경계가 없이 이어지는 걸 보았을 때 좌상엽이며 이걸 설분절 segment)이라고 합니다.

2017년 Q9 [노병학 교수님] 정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법

Q9. 흉부 단순촬영에 대한 설명이다. 다음 중 맞는 항은?

- ① 사진의 투과도는 폐문이 보이는지를 따진다.
- ② 대체로 우측 폐문이 좌측에 비해 약 1-2cm정도 높다.
- ③ 환자의 회전 여부는 양측 빗장뼈 머리의 중심선과 척추 극돌기가 일치하는지를 본다.
- ④ 후전위(PA)에서 우측 횡격막이 8번째 후방늑간(posterior intercostal space)에 있다면, 환자의 호흡 상태는 적당하다.
- ⑤ 양측 쇄골이 양측 폐첨부와 중첩되지 않으며, 늑골이 대각선 방향이며, 횡격막의 위치가 정상 위치라면, 흉부 단순촬영은 전후위(AP) 사진이다.

정답:

해설

8번째 아니고 10번째

PA 설명

2016년 Q9 [노병학] 정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법

Q9. 다음 그림은 우중엽과 우하엽이 보이는 흉부 CT 사진이다. 화살표가 가리키는 부위는 어느 segment인가?

- 1) RML lateral segment
- 2) RLL medial basal segment
- 3) RLL anterior basal segment
- 4) RLL lateral basal segment
- 5) RLL posterior basal segment

정답: 3

해설

우하엽(RLL)의 basal segment 배열은 CT에서 anterior basal이 앞쪽, medial basal이 안쪽, lateral basal이 외측, posterior basal이 뒤쪽에 위치한다. 화살표 위치가 anterior branch에 해당하므로 RLL anterior basal segment이다.